

«Сечокам'яна хвороба»

Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- в'яснити анамнез захворювання та життя;
- продемонструвати практичну навичку “Симптом Пастернацького”;
- виділити провідний синдром;
- надати рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви лікар терапевтичного відділення. До Вас звернувся чоловік.

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>	<i>Текст стандартизованого пацієнта</i>
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ.		
<i>Привітатися з пацієнтом</i>	Доброго дня.	Доброго дня.
<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікарка-терапевт, Катерина Іванівна. Я з Вами поспілкуюсь, огляну, проведу обстеження.	Добре
<i>Запитати пацієнтку, як до неї можна звертатися</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Олександр Миколайович
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	36 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви працюєте?	Я працюю водієм.
2.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
<i>Інформувати пацієнта про «лікарську таємницю»</i>	Олександр Миколайовичу, наша розмова цілком конфіденційна	Добре.
3.ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Олександр Миколайовичу, що Вас турбує?	Нестерпний біль у попереку, часте сечовипускання.
	Опишіть біль у попереку: де болить, кудись віддає?	Болить праворуч, віддає в пахову ділянку.

	Постійний чи приступоподібний біль, після чого проходить?	Приступоподібний. Приймав анальгін, але не допомогло.
	Сечовипускання болюче? Кров у сечі?	Так, сечовипускання болюче. Крові не бачив.
	Температура тіла підвищувалась?	Ні.
Запитати анамнез захворювання пацієнтки	Коли у Вас з'явилися скарги?	Все почалося 4 години тому.
	З чим пов'яжете?	Не знаю. Ми повернулись з дня народження і мене прихватило. Прийняв анальгін, не допомогло. Вирішив не чекати ночі, приїхав до Вас.
	Вживали гостру, жирну їжу, алкогольні напої?	Так, їжа була гострою з прянощами. Алкоголь майже не пив, тільки келих червоного вина.
	Раніше були подібні напади?	Ні.
Запитати анамнез життя пацієнтки	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет? Операції, травми протягом життя?	Ні
	Шкідливі звички?	Ні
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків?	Ні
	Спадковість: чи хтось у сім'ї хворів хронічними захворюваннями?	Ні
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
Попросити пацієнта зняти одяг	Будь ласка звільніть від одягу верхню половину тулуба, я Вам перевірю симптом Пастернацького.	Так, зараз.
ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.		
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА		
Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді		

	Визначення больових відчуттів в поперековій області зліва (лікар кладе свою одну руку на область XII ребра ліворуч від хребта і здійснює що до неї короткі удари другою рукою, стиснутою в кулак).	
	Визначення больових відчуттів	

	в поперековій області справа (лікар кладе свою одну руку на область XII ребра праворуч від хребта і здійснює що до неї короткі удари другою рукою, стиснутою в кулак).	
	Визначити «позитивний» чи «негативний» симптом Пастернацького: симптом Пастернацького позитивний праворуч	Коли здобувач освіти здійснить короткі удари праворуч – сказати «Боляче»
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Уточнити самопочуття</i>	Як Ви себе почувате, все добре? Одягайтеся.	Так.
<i>Пояснити подальші дії</i>	Олександр Миколайовичу, враховуючи Ваші скарги, раджу Вам подальше обстеження в стаціонарі для встановлення діагнозу і призначення ліків.	
5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром – біль в спині	Що робити?
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Спочатку треба відкоригувати дієту: Забороняється червоне м'ясо, оселедець, страви з тельбухами тварин. Не можна холодці, міцні бульйони, кислі рослини (щавель, салат, шпинат). Потрібно відмовитися від маринадів, копченостей, приправ у вигляді хрону, гірчиці, аджики. Протипоказаний алкоголь у будь-якому вигляді. Рекомендується обмежити споживання кальцію та фосфору. Дозволяються свіжі овочі та фрукти, рослинні олії. Не впливають на уролітіаз борошняні страви, мед, каші та крупи.	Дякую, лікарю
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		

	Олександрє Миколайовичу, чи Вам все зрозуміло?	Все зрозумів
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає

	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.
--	--	--------------------------------